

CISVALI
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu



FORMULÁRIO DE ESTRATIFICAÇÃO DO HIPERTENSO

Município de Residência:	Data do encaminhamento:
Enfermeiro Responsável:	Data de Recebimento no CIS:

DADOS PESSOAIS

Nome Completo: Identidade:

Telefone: Data Nasc.: CNS:

Nome do acompanhante:

ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO - HIPERTENSO

Fatores de risco	Pontuação 1 ou 0
1. Sexo masculino	
2. Idade: homens ≥ 55 anos mulheres ≥ 65 anos	
3. Tabagismo	
4. História de doença cardiovascular prematura em parentes de 1º grau: homens < 55 anos mulheres < 65 anos	
5. Dislipidemia: LDL colesterol > 100 mg/dL ou HDL: homens < 40 mg/dL mulheres < 46 mg/dL ou Triglicerídeos > 150 mg/dL	
6. Resistência à insulina: Glicemia plasmática em jejum: 100-125 mg/dL ou Teste oral de tolerância à glicose: 140-190 mg/dL em 2 horas ou Hemoglobina glicada: 5,7-6,4%	
7. Obesidade Índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m² ou Circunf. abdominal: homens ≥ 102cm mulheres ≥ 88cm Creatinina: Ácido úrico: Potássio: Urina: Eletrocardiograma:	
Total de pontos:	

Lesão de Órgão Alvo	Sim ou Não
1. Hipertrofia ventricular esquerda <u>Eletrocardiograma:</u> Índice Sokolow-Lyon (SV1+RV5 ou RV6) ≥ 35mm RaVL > 11 mm Cornell voltagem > 2440 mm*ms <u>Ecocardiograma:</u> Índice de massa ventricular esquerda > 115 g/m² homens, > 95 g/m² nas mulheres	
2. Espessura mediointimal da carótida > p75 para sexo/idade e raça ou placa carótídea	
3. Velocidade da onda de pulso carótido-femoral > 10m/s	
4. Índice tornozelo-braquial < 0,9	
5. Doença renal crônica estágio 3 (ritmo de filtração glomerular estimado entre 30 e 60 mL/min/1,73m²)	
6. Albuminúria entre 30 e 300 mg/24hs ou relação albumina/creatinina urinária 30 a 300mg	
Doença cardiovascular e doença renal estabelecidas	Sim ou Não
1. Doença cerebrovascular: Acidente vascular encefálico isquêmico, Hemorragia cerebral, Ataque isquêmico transitório	
2. Doença da artéria coronária: Angina estável ou instável, Infarto do miocárdio, Revascularização do miocárdio percutânea (angioplastia) ou cirúrgica, Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou preservada, Doença arterial periférica sintomática dos membros inferiores, Doença renal crônica estágio 4 (ritmo de filtração glomerular estimado entre <30 ml/min/1,73m² ou albuminúria >300mg/24hs), Retinopatia avançada (hemorragias, exsudatos, papiledema)	

CISVALI

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu

Estratificação de Risco	Pressão arterial: (em mmHg)			
	☐ Sistólica: 130 a 139 ou Diastólica: 85 a 89	Sistólica: 140 a 159 ou ☐ Diastólica: 90 a 99	☐ Sistólica: 160 a 179 ou Diastólica: 100 a 109	☐ Sistólica: ≥ 180 ou ☐ Diastólica: ≥ 110
☐ Nenhum fator de risco	Sem risco adicional	Baixo risco	Risco moderado	Risco alto
☐ 1 a 2 fatores de risco	Baixo risco	Risco moderado	Risco alto	Risco alto
☐ ≥3 fatores de risco	Risco moderado	Risco alto	Risco alto	Risco alto
☐ Lesão em órgãos-alvo, doença cardiovascular, doença renal crônica, diabetes mellitus	Risco alto	Risco alto	Risco alto	Risco alto

Quadro 5.5 – Fatores que podem modificar o risco do paciente hipertenso

História familiar ou nos pais de início precoce de hipertensão arterial

Nível muito elevado de um FR individual, incluindo HA estágio 3

Eclâmpsia/pré-eclâmpsia prévia

Apneia do sono

Pressão de pulso > 60 (em pacientes idosos)

Ácido úrico > 7 mg/dL (homens) e > 5,7 mg/dL (mulheres) (GR: I, nível: C)

Proteína C-reativa ultrasensível > 2mg/L (GR: I, nível: B)

FC > 80 bpm

Síndrome metabólica*

Sedentarismo

Fatores psicossociais e econômicos

Distúrbios inflamatórios crônicos

HISTÓRIA PREGRESSA

Descrever resumo histórico pregresso da condição de saúde do usuário, todos os dados relevantes, como internamentos e tratamentos realizados. Anexar todos os exames realizados e avaliações ponderais (peso, altura, IMC, CA, HGT, FC, etc).

CISVALI
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu

TERAPIA MEDICAMENTOSA

Alergia Medicamentosa:

Automedicação:

☐ AAS 100 mg ☐ 1x/d	☐ Anlodipino 5mg ☐ 1x/d ☐ 12/12h
☐ Amiodarona 200 mg ☐ 1x/d ☐ x/sem	☐ Atenolol ☐ 25 - ☐ 50 mg ☐ 1x/d ☐ 12/12h
☐ Atorvastatina ☐ 40 - ☐ 80 mg, ☐ 1x/d	☐ Cilostazol 100 mg, ☐ 1x/d ☐ 12/12h
☐ Ciprofibrato 100 mg, ☐ 1x/d	☐ Captopril ☐ 25 - ☐ 50 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h
☐ Carvedilol 3,125 - ☐ 12,5 - ☐ 25 mg, ☐ x/d,	☐ Cloridrato de Hidralazina ☐ 25mg ☐ 50mg
☐ Enalapril ☐ 10 - ☐ 20 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h	☐ Cloridrato de Verapamil ☐ 80mg ☐ 120mg
☐ Espironolactona 25 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h	☐ x ao dia
☐ Fenofibrato 200mg, ☐ 1x/d	☐ Furosemida 40 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h
☐ Glibenclamida 5 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h	☐ Hidroclorotiazida 25 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h
☐ Insulina NPH ☐ unidades, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h	☐ Isossorbida 20 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h
☐ Losartana 50 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h	☐ Insulina Regular ☐ unidades, ☐ 1x/d,
☐ Levotiroxina ☐ 25 - ☐ 50 - ☐ 75 - ☐ 100 mcg ☐	☐ 8/8h, ☐ 12/12h
mcg ☐ 1x/jejum	☐ Metformina ☐ 500 - ☐ 850 mg, ☐ 1x/d,
☐ Metoprolol ☐ 25 - ☐ 50 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h	☐ 12/12h
☐ Propranolol ☐ 20 - ☐ 40 mg, ☐ 1x/d, ☐ 12/12h	☐ Sinvastatina ☐ 20 - ☐ 40 mg, ☐ 1x/d

Outras medicações:

Quadro 6.1 – Metas pressóricas gerais a serem obtidas com o tratamento anti-hipertensivo

Meta	Risco cardiovascular	
	Baixo ou moderado	Alto
PA sistólica (mmHg)	< 140	120-129
PA diastólica (mmHg)	< 90	70-79

Quadro 6.2 – Metas de tratamento para idosos considerando a condição global e a medida da pressão arterial no consultório.

Condição global ¹	PAS de consultório		PAD de consultório	
	Limiar de tratamento	Meta pressórica ^{4,5}	Limiar de tratamento	Meta ⁸
Hígidos ²	≥140 (I, A)	130-139 (I, A) ⁶	≥90	70-79
Idosos frágeis ³	≥160 (I, C)	140-149 (I, C) ⁷	≥90	70-79

1: mais importante a condição funcional que idade cronológica; 2: incluindo fragilidade leve; 3: fragilidade moderada a severa; 4: incluindo idosos com comorbidades: DM, DAC, DRC, ACV/EIT (não se refere à fase aguda); 5: avaliar ativamente a tolerabilidade, inclusive possíveis sintomas atípicos; 6: uma meta mais rígida (125-135 mmHg) pode ser obtida em casos selecionados, especialmente em idosos motivados, com < 80 anos, apresentando ótima tolerabilidade ao tratamento; 7: limites mais elevados em caso de sobrevida limitada e ausência de sintomas. A redução da PA deve ser gradual; 8: PAD = evitar < 65-70 mmHg em portadores de DAC clinicamente manifesta.

CISVALI
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu

CONTROLE PRESSÓRICO

	Data	Manhã	Tarde	Noite
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

ADESÃO TERAPÊUTICA

☐ NÃO Aderente ☐ Pouco Aderente ☐ Aderente

Local e Data

Assinatura/Carimbo do Solicitante

PARA USO DO CONSÓRCIO

DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO

Motivo da Devolução: _____

Data da Devolução: _____

Assinatura: _____